



暴食性障碍

作者: [Evelyn Attia](#), MD, Columbia University Medical Center;
[B. Timothy Walsh](#), MD, College of Physicians and Surgeons, Columbia University
Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry
已审核/已修订 8月 2025 | 修改的 1月 2026

暴食性障碍是一种**进食/饮食障碍**，其特征是无法自控地进食异常大量的食物（暴食），但期间和之后并无减轻体重的尝试（催吐）。暴食后不会产生对过量进食的弥补行为——例如去除身体内过多的食物（清除行为）。

- 暴食性障碍在超重或肥胖者中更常见。
- 暴食性障碍患者短时间内摄入大量食物后并不进行催吐，常为其暴食行为而烦恼。
- 诊断依据于患者对其异常行为的描述。
- 治疗目的是帮助患者控制暴食，包括使用认知行为疗法、选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI，一种抗抑郁药）和兴奋剂。
- 减肥项目、某些减肥药物和兴奋剂可以帮助控制体重。

总体而言，约有 1% 至 2% 的女性和不到 1% 的男性患有暴食性障碍。但该障碍随着体重的增加而更常见。在某些减重课程中，17% 至 27% 或更多的肥胖者存在此障碍。

多数暴食性障碍患者存在超重或肥胖，而该障碍又导致他们摄入过量卡路里。与此相反，**神经性贪食症**患者体重正常，而**神经性厌食症**患者消瘦。本病患者的年龄比神经性厌食症或神经性贪食症高，近半数男性。

肠道微生物的基因变异可能是导致暴饮暴食症的原因之一。

暴食性障碍的症状

一次暴食期间，患者摄入大量食物，远远超出多数人在同等时间同等情形下所摄入的食物量。环境和文化很重要，因为平时用餐的过量标准与节假日用餐的过量标准可能不同。在暴食过程中和暴食后，患者感觉自己好像失去控制，并感到痛苦。暴食性障碍患者不会通过清除（使自己呕吐、滥用泻药、利尿剂或灌肠）、过度锻炼或禁食来弥补暴食。与持续过度进食不同，暴食呈阵发性。

暴食性障碍患者还可能做以下事情：

- 进食速度较正常人增快

- 过度进食直到感到胃部不适
- 非饥饿状态下进食大量食物
- 因对自己的行为感到羞愧，常独自就餐
- 暴食后常感到自责、抑郁或自罪

暴食性障碍患者常为其暴食行为而烦恼，特别是当他们正在努力减肥时。患者比正常人更容易出现[抑郁](#)或[焦虑](#)。

肥胖症和暴食性障碍之间存在强烈关联。与非暴食者相比，患有这两种疾病的人更有可能专注于体形、体重或两者。他们患[高血压](#)和[糖尿病](#)等与肥胖有关的并发症的风险也更高。

暴食性障碍的诊断

- 医生根据标准精神病标准进行评估

医生根据以下情况诊断暴食性障碍

- 患者报告称每周暴食至少一次，至少持续 3 个月。
- 暴食伴随对进食的失控感。
- 患者存在典型的症状和行为。

暴食性障碍的治疗

- 心理治疗
- 某些抗抑郁药和兴奋剂
- 可采用减肥药和抑制食欲的药物
- 自助小组和传统减肥项目可能有效

其他的治疗方法还包括：

- **认知行为疗法**从长远来讲有助于控制暴食，但对体重影响甚微。
- **人际心理治疗**的效果等同于认知行为治疗，但对体重也同样效果甚微。
- **兴奋剂**（例如用于治疗注意力缺陷/多动症 [ADHD] 的药物）和氟西汀等**选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂**（一种抗抑郁药）可以帮助患者短时间停止暴食，并可能使体重减轻。
- **减肥药**（如奥利司他）或食欲抑制剂（如托吡酯）可能有助于减轻体重。
- 与“匿名戒酒自助会”类似的**自助团体**（如匿名暴食和食物成瘾自助会）分布广泛，但作用仍不确定。
- **传统的行为减肥项目**可帮助患者减肥并短时间停止暴食，但患者往往会重新开始暴食。
- 可采用**针对重度肥胖的手术治疗**，但其对暴食的长期作用仍不清楚。

了解更多信息

以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[美国进食障碍帮助协会 \(NEDA\)](#)

[美国国家神经性厌食症和相关疾病协会 \(ANAD\)](#)

[美国国立精神研究卫生研究所 \(NIMH\)，进食障碍](#)